GOTOWY PLAN LECZENIA™ · MATERIAŁ GŁÓWNY

Gotowe Plany Leczenia dla 40 Typów Przypadków

Od diagnozy po retencję, 4-etapowy gotowy schemat dla każdego typu przypadku: należy otworzyć plan zaraz po zakończeniu badania i dostosować go do dokumentacji pacjenta.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak korzystać

Indeks 40 planów

Część A · Klasa I · Stłoczenia, szpary i protruzja

Część B · Problemy poprzeczne · Zgryz krzyżowy

Część C · Przypadki klasy II

Część D · Przypadki klasy III

Część E · Problemy pionowe · Zgryz otwarty i głęboki

Część F · Problemy zębowe i brak miejsca

Część G · Pacjenci dorośli, interdyscyplinarni i specjalni

Jak korzystać

> *Każdy plan został napisany w tej samej kolejności, co **4-Etapowy Planer Kliniczny** w Kompendium: diagnoza i dokumentacja, cele i decyzje, sekwencja mechaniki, wykończenie i retencja. Po zakończeniu badania należy znaleźć typ przypadku, otworzyć plan i dostosować go do dokumentacji pacjenta.*

1. Należy sklasyfikować przypadek pod kątem strzałkowym, pionowym, poprzecznym oraz problemów z miejscem (Szybki bonus: Selektor Typu Przypadku).
2. Należy znaleźć w indeksie numer najbliższego planu.
3. Należy uzupełnić etapy diagnozy i dokumentacji danymi pacjenta.
4. Należy wpisać cele i decyzje do karty pacjenta.
5. Należy przenieść sekwencję mechaniki do planu wizyt.
6. Należy sprawdzić punkty dotyczące wykończenia i retencji przed dniem zdjęcia aparatu.

> **Ważne:** Te plany stanowią szkielet początkowy. Siły, rozmiary łuków, ustawienia aparatów i czas trwania określa się na podstawie dokumentacji pacjenta, fazy wzrostu oraz decyzji klinicznej lekarza.

Indeks 40 planów

A · Klasa I · Stłoczenia, szpary i protruzja

01	Klasa I · Łagodne stłoczenie
02	Klasa I · Umiarkowane stłoczenie
03	Klasa I · Ciężkie stłoczenie (plan z ekstrakcją)
04	Łuk ze szparami (diastemy uogólnione)
05	Diastema między siekaczami górnymi
06	Protruzja dwuszczękowa

B · Problemy poprzeczne · Zgryz krzyżowy

07	Zgryz krzyżowy pojedynczego zęba przedniego
08	Jednostronny zgryz krzyżowy boczny (przesunięcie czynnościowe)
09	Obustronne zwężenie szczęki w okresie wzrostu
10	Zwężenie poprzeczne u dorosłych

C · Przypadki klasy II

11	Klasa II/1 · Retruzja żuchwy w okresie wzrostu
12	Klasa II/1 · Kamuflaż u dorosłych
13	Klasa II/2 · Zgryz głęboki
14	Klasa II zębowa · Dystalizacja trzonowców
15	Jednostronna klasa II (subdywizja)
16	Wczesna interwencja · Zwiększony overjet i niewydolność warg

D · Przypadki klasy III

17	Pseudo klasa III (czynnościowa)
18	Retruzja szczęki w okresie wzrostu
19	Łagodny kamuflaż klasy III u dorosłych
20	Przygotowanie ortodontyczne do chirurgii ortognatycznej

E · Problemy pionowe · Zgryz otwarty i głęboki

21	Zgryz otwarty u dziecka wynikający z nawyków
22	Zgryz otwarty zębodołowy u dorosłych
23	Zgryz otwarty szkieletowy (hiperdywergentny)

24	Zgryz głęboki (hipodywergentny)
25	Zgryz głęboki i nadmierne eksponowanie dziąseł

F · Problemy zębowe i brak miejsca

26	Zatrzymany kieł górny
27	Wrodzony brak siekacza bocznego górnego
28	Wrodzony brak drugiego przedtrzonowca dolnego
29	Wczesna utrata zęba mlecznego · Utrzymywacz przestrzeni
30	Pionizacja trzonowca (przed protetyką)
31	Ektopowe wyrzynanie pierwszego trzonowca
32	Ząb nadliczbowy i opóźnione wyrzynanie

G · Pacjenci dorośli, interdyscyplinarni i specjalni

33	Pacjent dorosły z problemami przyzębia
34	Uporządkowanie miejsca przed implantacją
35	Nawrót · Stłoczenie siekaczy dolnych
36	Niezgodność Boltona (małe siekacze boczne)
37	Przesunięcie linii środkowej
38	Leczenie ograniczone (odcinek przedni) u dorosłych
39	Korekta odcinka przedniego w uzębieniu mieszanym (2×4)
40	Stłoczenie siekaczy dolnych · Rozwiązanie z IPR

Część A • Klasa I • Stłoczenia, szpary i protruzja

PLAN 01 Klasa I • Łagodne stłoczenie

Typowe objawy: Relacja trzonowcowa i kłowa klasy I, relacja szkieletowa zrównoważona, łagodne nieprawidłowości długości łuku; profil akceptowalny.

Cele leczenia: Rozwiązanie stłoczenia bez ekstrakcji · Zachowanie nachylenia siekaczy · Niezaburzanie profilu

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Obliczyć zapotrzebowanie na miejsce za pomocą analizy modeli
- Zarejestrować nachylenie siekaczy w cefalometrii
- Odnotować biotyp dziąsła i wsparcie kostne wargowe

2 · CELE I DECYZJE

- Plan bez ekstrakcji; w razie potrzeby ograniczone IPR jako źródło miejsca
- Określić granicę proklinacji na początku leczenia

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Pełne założenie zamków lub plan z nakładkami
2. Niwelacja lekkimi, elastycznymi łukami
3. W razie potrzeby kontrolowane IPR w odcinkach bocznych
4. Przejście na łuk roboczy i ustalenie formy łuku

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Sprawdzić punkty styczne i brzegi brzeżne
- Rozważyć stały retainer językowy dla odcinka przedniego dolnego

Częsty błąd: Rozpoczęcie niwelacji bez pomiaru zapotrzebowania na miejsce, co prowadzi do niekontrolowanego wychylenia siekaczy.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 02 Klasa I · Umiarkowane stłoczenie

Typowe objawy: Relacja klasy I; wyraźna nieprawidłowość długości łuku, nachylenie siekaczy prawidłowe lub lekko zwiększone.

Cele leczenia: Świadomy wybór źródła miejsca · Kontrola pozycji siekaczy · Zachowanie zgryzu

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Analiza miejsca + cefalometria + zdjęcie profilowe
- Ocenienie wsparcia warg i kąta nosowo-wargowego
- Odnotowanie granic dziąsła i kości

2 · CELE I DECYZJE

- Kolejność źródeł miejsca: IPR, ograniczona ekspansja, dystalizacja, ostateczność: ekstrakcja
- Potwierdzenie decyzji za pomocą Narzędzia 2 · Mapa Decyzyjna: Ekstrakcja czy Zachowanie?

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Założenie zamków i niwelacja lekkimi łukami
2. Zastosowanie wybranego źródła miejsca
3. Przejście na łuk roboczy z zachowaniem formy łuku
4. Sprawdzenie linii środkowej i zgryzu

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Doginanie łuków wykończeniowych i detale
- Plan retencji dla łuku dolnego i górnego

Częsty błąd: Rozpoczęcie leczenia bez decyzji o źródle miejsca i zmiana planu w trakcie.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 03 Klasa I · Ciężkie stłoczenie (plan z ekstrakcją)

Typowe objawy: Relacja klasy I; nieprawidłowość długości łuku niemożliwa do rozwiązania bez ekstrakcji, siekacze wychylone lub nadmierne wsparcie warg.

Cele leczenia: Rozwiązanie stłoczenia przez ekstrakcję · Poprawa pozycji siekaczy · Kontrola zakotwienia

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Pełny zestaw dokumentacji: modele, pantomogram, cefalometria, zdjęcia
- Określenie zębów do ekstrakcji na podstawie zdrowia zębów i potrzeb zakotwienia

2 · CELE I DECYZJE

- Decyzja o ekstrakcji i klasie zakotwienia (maksymalne, umiarkowane, minimalne)
- W razie potrzeby miniimplanty lub łuk podniebienny dla zakotwienia

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja po ekstrakcji i dystalizacja kłów
2. Retrakcja siekaczy lub zamykanie szpar en masse
3. Weryfikacja zakotwienia na każdej wizycie poprzez relację trzonowców
4. Kontrola równoległości korzeni na pantomogramie

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Równoległość korzeni w miejscach ekstrakcji
- Plan długoterminowej retencji

Częsty błąd: Rozpoczęcie zamykania szpar bez określenia klasy zakotwienia i utrata relacji trzonowcowej.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 04 Łuk ze szparami (diastemy uogólnione)

Typowe objawy: Szpary w łuku, zęby małe w stosunku do długości łuku lub łuk szeroki; możliwy wpływ języka lub nawyków.

Cele leczenia: Zamknięcie szpar lub rozdzielenie miejsca pod protetykę · Kontrola nachylenia siekaczy · Zapobieganie nawrotom

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Ilość i rozkład szpar
- Analiza Boltona (zgodność rozmiarów zębów)
- Pozycja języka i wywiad dotyczący nawyków

2 · CELE I DECYZJE

- Zamknięcie całkowite czy rozdzielenie miejsca pod uzupełnienia protetyczne? Decyzja z lekarzem prowadzącym leczenie odtwórcze
- Jeśli występuje nawyk, najpierw należy go wyeliminować

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Zamknięcie szpar łańcuchem elastycznym lub sprężyną zamykającą
3. Monitorowanie nadmiernej retrakcji siekaczy
4. W razie potrzeby pozostawienie miejsca na uzupełnienia

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Przyjęcie konieczności stałego retainera
- Jeśli planowana jest protetyka, zaplanowanie retainera po zakończeniu prac protetycznych

Częsty błąd: Zakończenie leczenia bez zamknięcia szpar i założenia stałego retainera.

Szczegóły: Moduł 08 · Wykończenie i stabilność

PLAN 05 Diastema między siekaczami górnymi

Typowe objawy: Szpara między siekaczami przyśrodkowymi; wędzidełko może być grube lub nisko przyczepione, możliwy ząb nadliczbowy.

Cele leczenia: Zamknięcie diastemy · Wyeliminowanie przyczyny · Zapobieganie nawrotom

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Kontrola mezjodensa za pomocą zdjęcia okołowierzchołkowego lub pantomogramu
- Test blanszowania wędzidełka
- Nachylenie siekaczy i rozmiar zębów

2 · CELE I DECYZJE

- Jeśli istnieje przyczyna, najpierw przyczyna: mezjodens, wędzidełko, nawyk
- Zaplanowanie czasu frenektomii z chirurgiem (zazwyczaj po zamknięciu)

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zamki odcinkowe na siekacze
2. Zamknięcie szpary z zachowaniem równoległości korzeni
3. Po zamknięciu w razie potrzeby frenektomia
4. Kontrola

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stały retainer podniebienny
- Długoterminowa obserwacja

Częsty błąd: Zbliżenie koron, a nie korzeni, co prowadzi do szybkiego nawrotu.

Szczegóły: Moduł 08 · Wykończenie i stabilność

Skierowanie: Mezjodens lub grube wędzidełko: chirurgia stomatologiczna / periodontologia.

PLAN 06 Protruzja dwuszczękowa

Typowe objawy: Relacja klasy I; siekacze dolne i górne wychylone, wargi pełne i napięte, możliwe trudności z domykaniem warg.

Cele leczenia: Retrakcja siekaczy · Zmniejszenie wsparcia warg · Utrzymanie maksymalnego zakotwienia

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Cefalometryczne nachylenie siekaczy i linie warg
- Zdjęcie profilowe i oczekiwania estetyczne pacjenta
- Wsparcie kostne i dziąsło

2 · CELE I DECYZJE

- Zazwyczaj plan z ekstrakcją czterech przedtrzonowców
- Maksymalne zakotwienie: miniimplanty lub opcje wsparcia zewnątrzustnego

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Dystalizacja kłów lub retrakcja en masse
3. Retrakcja siekaczy z kontrolą torku
4. Monitorowanie zmiany profilu za pomocą zdjęć

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Równoległość korzeni i tork
- Retainer dolny i górny

Częsty błąd: Retrakcja siekaczy bez kontroli torku i zakończenie leczenia z wychylonymi siekaczami.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

Część B • Problemy poprzeczne • Zgryz krzyżowy

PLAN 07 Zgryz krzyżowy pojedynczego zęba przedniego

Typowe objawy: Jeden siekacz górny za dolnymi; relacja szkieletowa zrównoważona, możliwe przesunięcie w zgryzie.

Cele leczenia: Wyprowadzenie zęba ze zgryzu krzyżowego · Wyeliminowanie przesunięcia czynnościowego

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Przesunięcie między relacją centralną a zgryzem
- Czy jest miejsce przed zębem?
- Kształt korzenia i wsparcie kostne

2 · CELE I DECYZJE

- Jeśli jest wystarczająco miejsca, korekta miejscowa
- Jeśli brak miejsca, najpierw uzyskanie miejsca

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. W razie potrzeby podniesienie zgryzu (dla odblokowania)
2. Wyprowadzenie zęba za pomocą zamków odcinkowych lub aparatu ruchomego
3. Przyjęcie stabilności po uzyskaniu nagryzu poziomego

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola wystarczającego nagryzu pionowego
- Krótkoterminowy retainer

Częsty błąd: Forsowanie zęba bez odblokowania zgryzu i złamanie aparatu.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

PLAN 08 Jednostronny zgryz krzyżowy boczny (przesunięcie czynnościowe)

Typowe objawy: Zgryz krzyżowy jednostronny, żuchwa przesuwa się na bok w zgryzie, przesunięcie linii środkowej pogłębia się w zgryzie.

Cele leczenia: Wyeliminowanie przesunięcia · Symetryczna ekspansja łuku górnego

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Porównanie linii środkowej przy otwartych i zamkniętych ustach
- Szerokość łuku górnego i nachylenie trzonowców
- Okres wzrostu

2 · CELE I DECYZJE

- Czy to prawdziwy zgryz jednostronny, czy wynikający z przesunięcia? Rozróżnić
- Jeśli występuje przesunięcie, symetryczna ekspansja łuku górnego

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Aparat do ekspansji (wybór w zależności od okresu wzrostu)
2. Czas retencji po ekspansji
3. W razie potrzeby wykończenie leczeniem stałym

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola linii środkowej i zgryzu
- Retainer poprzeczny

Częsty błąd: Zastosowanie jednostronnej asymetrycznej mechaniki bez zauważenia przesunięcia.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

PLAN 09 Obustronne zwężenie szczęki w okresie wzrostu

Typowe objawy: Obustronny zgryz krzyżowy boczny lub wąski łuk górny, szerokie korytarze policzkowe, należy sprawdzić oddychanie przez nos.

Cele leczenia: Ekspansja szkieletowa szczęki · Uzyskanie miejsca w łuku

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Ocena wzrostu i dojrzałości szwów
- Dokumentacja okluzyjna lub pantomogram
- Wywiad dotyczący oddychania i nawyków

2 · CELE I DECYZJE

- Wybór aparatu do szybkiej ekspansji szczęki
- Jeśli występuje problem z oddychaniem, konsultacja laryngologiczna

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zastosowanie aparatu i program aktywacji
2. Po ekspansji pozostawienie aparatu jako pasywnego dla retencji
3. Następnie leczenie stałe lub obserwacja

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stabilność poprzeczna
- W razie potrzeby retainer nocny

Częsty błąd: Zbyt krótki czas retencji i nawrót ekspansji.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

Skierowanie: Oddychanie ustami i chrapanie: laryngolog.

PLAN 10 Zwężenie poprzeczne u dorosłych

Typowe objawy: Wąski łuk górny i zgryz krzyżowy u dorosłego; szwy dojrzałe, obecna kompensacja zębowa.

Cele leczenia: Wybór możliwej ekspansji · Ochrona granic przyzębia

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Nachylenie trzonowców i grubość kości policzkowej
- Ryzyko recesji dziąseł
- Czy problem jest zębowy czy szkieletowy?

2 · CELE I DECYZJE

- Ekspansja zębowa ograniczona, przy zwężeniu szkieletowym opcje ekspansji wspomaganej miniimplantami lub chirurgicznie
- Decyzję podjąć wspólnie z pacjentem i na piśmie

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wybrana metoda ekspansji
2. Łuk i tork kontrolujący nachylenie trzonowców
3. Wykończenie leczeniem stałym

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola przyzębia
- Retainer poprzeczny

Częsty błąd: Próba rozwiązania problemu szkieletowego ekspansją zębową i wychylenie zębów w stronę policzkową.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

Skierowanie: Zwężenie szkieletowe: chirurgia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa.

Część C · Przypadki klasy II

PLAN 11 Klasa II/1 · Retruzja żuchwy w okresie wzrostu

Typowe objawy: Zwiększony overjet, klasa II trzonowcowa, retruzja żuchwy, potencjał wzrostowy.

Cele leczenia: Sterowanie wzrostem · Zmniejszenie overjetu · Zmniejszenie ryzyka urazu siekaczy

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Ocena okresu wzrostu
- Składniki szkieletowe i zębowe w cefalometrii
- Zdolność pacjenta do współpracy

2 · CELE I DECYZJE

- Czas zastosowania aparatu czynnościowego w zależności od skoku wzrostowego
- Aparat ruchomy czy stały czynnościowy? W zależności od współpracy

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Okres aparatu czynnościowego
2. Pomiar trzonowców i overjetu podczas kontroli
3. Następnie wykończenie leczeniem stałym

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Ustalenie relacji klasy I
- Retencja retainerem nocnym lub aktywatorem

Częsty błąd: Przegapienie okresu wzrostu i późne rozpoczęcie leczenia czynnościowego.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

PLAN 12 Klasa II/1 · Kamuflaż u dorosłych

Typowe objawy: Dorosły, relacja szkieletowa klasy II łagodna–umiarkowana, zwiększony overjet, pacjent nie chce chirurgii.

Cele leczenia: Zamknięcie overjetu ruchami zębowymi · Utrzymanie akceptowalnego profilu

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Wielkość różnicy szkieletowej
- Analiza profilu i warg
- Oczekiwania estetyczne pacjenta

2 · CELE I DECYZJE

- Czy na granicy kamuflażu? Jeśli tak, przedstawić opcję chirurgiczną
- Zazwyczaj plan z ekstrakcją przedtrzonowców górnych; plan zakotwienia

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Dystalizacja kłów górnych
3. Retrakcja siekaczy górnych z kontrolą torku
4. Zakończenie z kłami w klasie I, trzonowcami w klasie II

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Tork siekaczy i overbite
- Retainer

Częsty błąd: Kontynuowanie leczenia w przypadku przekraczającym granice kamuflażu aż do pogorszenia profilu.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

Skierowanie: Wyraźna klasa II szkieletowa: konsultacja ortognatyczna.

PLAN 13 Klasa II/2 · Zgryz głęboki

Typowe objawy: Siekacze górne retroklinowane, kły mogą być przed nimi, zgryz głęboki, silny mięsień wargowy.

Cele leczenia: Korekta nachylenia siekaczy · Otwarcie zgryzu głębokiego · Korekta relacji klasy II

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Nachylenie siekaczy i overbite
- Eksponowanie dziąseł i linia uśmiechu
- Wywiad dotyczący SSŻ

2 · CELE I DECYZJE

- Najpierw skorygować tork siekaczy, potem zająć się problemem strzałkowym
- Jeśli występuje wzrost, przed aparatem czynnościowym wychylić siekacze

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Protruzja i tork siekaczy górnych
2. Mechanika otwierania zgryzu (intruzja lub ekstruzja boczna, w zależności od przypadku)
3. Korekta klasy II

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stabilność overbite
- Stały retainer podniebienny

Częsty błąd: Użycie wyciągów klasy II bez otwarcia zgryzu głębokiego i forsowanie siekaczy.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

PLAN 14 Klasa II zębowa · Dystalizacja trzonowców

Typowe objawy: Relacja szkieletowa zrównoważona, trzonowce górne mezjalnie, klasa II trzonowcowa, profil dobry.

Cele leczenia: Ustalenie klasy I trzonowców · Leczenie bez ekstrakcji

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Czy jest miejsce za trzonowcami? (zęby mądrości)
- Typ twarzy pionowy

2 · CELE I DECYZJE

- Aparat do dystalizacji lub dystalizacja wspomagana miniimplantami
- Plan zapobiegania utracie zakotwienia

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Dystalizacja trzonowców
2. Dystalizacja przedtrzonowców i kłów w kolejności
3. Retrakcja odcinka przedniego

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Klasa I trzonowców i kłów
- Retainer

Częsty błąd: Przeoczenie przemieszczania się odcinka przedniego do przodu (utrata zakotwienia) podczas dystalizacji.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 15 Jednostronna klasa II (subdywizja)

Typowe objawy: Po jednej stronie klasa I, po drugiej klasa II; może towarzyszyć przesunięcie linii środkowej.

Cele leczenia: Korekta asymetrii · Wyrównanie linii środkowych

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Czy asymetria jest zębowa czy szkieletowa?
- Pozycja linii środkowych względem twarzy
- Czy występuje przesunięcie czynnościowe?

2 · CELE I DECYZJE

- Ekstrakcja asymetryczna, wyciągi asymetryczne lub dystalizacja jednostronna
- Opcja chirurgiczna w asymetrii szkieletowej

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Symetryczna niwelacja
2. Wybrana mechanika asymetryczna
3. Kontrola linii środkowej na każdej wizycie

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Linia środkowa i relacja kłów
- Retainer

Częsty błąd: Forsowanie asymetrii szkieletowej mechaniką zębową.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

PLAN 16 Wczesna interwencja · Zwiększony overjet i niewydolność warg

Typowe objawy: Uzębienie mieszane, wyraźny overjet, wargi nie przykrywają siekaczy, wysokie ryzyko urazu.

Cele leczenia: Zmniejszenie ryzyka urazu · Sterowanie wzrostem

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Historia urazów
- Nawyki (ssanie palca)
- Okres wzrostu

2 · CELE I DECYZJE

- Faza wczesna czy pozostawienie na drugą fazę? W zależności od ryzyka i współpracy
- Omówienie z rodziną planu dwufazowego

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Kontrola nawyków
2. Aparat czynnościowy lub ograniczona mechanika stała
3. Obserwacja i czas drugiej fazy

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Retainer chroniący zyski
- Ocena drugiej fazy

Częsty błąd: Przedłużanie wczesnej fazy i męczenie pacjenta oraz rodziny.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

Część D · Przypadki klasy III

PLAN 17 Pseudo klasa III (czynnościowa)

Typowe objawy: Przesunięcie do przodu w zgryzie, siekacze w zgryzie czołowym w relacji centralnej, relacja szkieletowa normalna.

Cele leczenia: Wyeliminowanie przesunięcia · Ustalenie normalnego overjetu siekaczy

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Różnica między relacją centralną a zgryzem
- Nachylenie siekaczy
- Wywiad rodzinny

2 · CELE I DECYZJE

- Wczesna korekta zazwyczaj korzystna
- Prosta mechanika może być wystarczająca

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wychylenie siekaczy górnych
2. W razie potrzeby podniesienie zgryzu
3. Zakończenie po uzyskaniu pozytywnego overjetu i overbite

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola overbite
- Obserwacja wzrostu

Częsty błąd: Pomylenie prawdziwej klasy III szkieletowej z pseudo.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

PLAN 18 Retruzja szczęki w okresie wzrostu

Typowe objawy: Klasa III szkieletowa, retruzja szczęki, uzębienie mieszane lub wczesne uzębienie stałe.

Cele leczenia: Wspieranie rozwoju szczęki · Uzyskanie pozytywnego overjetu

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Okres wzrostu
- Pozycja szczęki i żuchwy w cefalometrii
- Wywiad rodzinny i rokowanie

2 · CELE I DECYZJE

- Maska twarzowa (w razie potrzeby z ekspansją) we wczesnym okresie
- Poinformowanie rodziny o nawrotach i możliwej potrzebie chirurgii na początku

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. W razie potrzeby ekspansja szczęki
2. Program maski twarzowej
3. Nadkorekta i obserwacja

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Obserwacja do końca wzrostu
- W razie potrzeby druga faza

Częsty błąd: Rozpoczęcie bez wyjaśnienia rodzinie rokowania i zaskoczenie potrzebą chirurgii w przyszłości.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

PLAN 19 Łagodny kamuflaż klasy III u dorosłych

Typowe objawy: Dorosły, łagodna klasa III szkieletowa, zgryz czołowy lub lekko negatywny overjet, profil akceptowalny.

Cele leczenia: Pozytywny overjet · Utrzymanie nachylenia siekaczy w akceptowalnych granicach

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Wielkość różnicy szkieletowej
- Wsparcie kostne siekaczy dolnych
- Oczekiwania pacjenta

2 · CELE I DECYZJE

- Ocena granicy kamuflażu; jeśli na granicy, przedstawić opcję chirurgiczną
- Źródło miejsca w łuku dolnym: IPR, ekstrakcja lub dystalizacja

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Mechanika klasy III (wyciągi lub wsparcie miniimplantami)
3. Kontrola torku siekaczy

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Overbite i overjet
- Retainer

Częsty błąd: Retrakcja siekaczy dolnych poza kość.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

Skierowanie: Wyraźna klasa III szkieletowa: chirurgia ortognatyczna.

PLAN 20 Przygotowanie ortodontyczne do chirurgii ortognatycznej

Typowe objawy: Wyraźna niezgodność szkieletowa, obecna kompensacja zębowa, pacjent otwarty na chirurgię.

Cele leczenia: Dekompensacja · Ustalenie zgodności łuków · Dokumentacja gotowa do chirurgii

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Pełny zestaw dokumentacji i wspólna ocena z chirurgiem
- Kierunek kompensacji

2 · CELE I DECYZJE

- Plan chirurgiczny wspólnie z chirurgiem; zadaniem ortodonty jest dekompensacja i zgodność łuków
- Jeśli wymagana ekstrakcja, w kierunku dekompensacji

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja i dekompensacja
2. Koordynacja łuków
3. Modele i dokumentacja przedchirurgiczna
4. Wykończenie pooperacyjne

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Ustalenie zgryzu
- Retainer

Częsty błąd: Zwiększanie kompensacji i utrudnianie chirurgii.

Szczegóły: Moduł 05 · Problemy strzałkowe

Skierowanie: Wspólny plan z chirurgią stomatologiczną i szczękowo-twarzową.

Część E · Problemy pionowe · Zgryz otwarty i głęboki

PLAN 21 Zgryz otwarty u dziecka wynikający z nawyków

Typowe objawy: Uzębienie mieszane, zgryz otwarty przedni, historia ssania palca lub tłoczenia języka.

Cele leczenia: Wyeliminowanie nawyku · Pozwolenie na samoistne zamknięcie zgryzu siekaczy

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Historia i częstotliwość nawyków
- Pozycja języka i połykanie
- Czy występuje składnik szkieletowy?

2 · CELE I DECYZJE

- Najpierw nawyk; aparat jest przypomnieniem, a nie karą
- W razie potrzeby wsparcie miofunkcjonalne

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Aparat przerywający nawyk (w zależności od przypadku)
2. Ćwiczenia języka
3. Obserwacja zamykania

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Monitorowanie nawrotu nawyku
- Ocena drugiej fazy

Częsty błąd: Próba zamknięcia zgryzu mechaniką stałą bez rozwiązania nawyku.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

Skierowanie: Problem z językiem i połykaniem: terapia miofunkcjonalna / laryngolog.

PLAN 22 Zgryz otwarty zębodołowy u dorosłych

Typowe objawy: Dorosły, zgryz otwarty przedni, struktura szkieletowa stosunkowo normalna, możliwy wpływ pozycji języka.

Cele leczenia: Zamknięcie zgryzu otwartego · Zapewnienie stabilności

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Rozróżnienie składników zębowych i szkieletowych
- Pozycja języka
- Relacja siekacz-warga i uśmiech

2 · CELE I DECYZJE

- Intruzja boczna (wsparcie miniimplantami) lub ekstruzja przednia: wybór w zależności od uśmiechu
- Plan treningu języka

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Wybrana mechanika pionowa
3. Kontrola overbite

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola nawyku językowego
- Długoterminowy retainer

Częsty błąd: Nadmierna ekstruzja siekaczy i zniszczenie uśmiechu oraz stabilności.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

PLAN 23 Zgryz otwarty szkieletowy (hiperdywergentny)

Typowe objawy: Duża wysokość dolnego odcinka twarzy, stromy płaszczyzna żuchwy, zgryz otwarty przedni.

Cele leczenia: Kontrola pionowa · Zamknięcie zgryzu lub przygotowanie do chirurgii

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Pionowe pomiary cefalometryczne
- Niewydolność warg i eksponowanie dziąseł

2 · CELE I DECYZJE

- Kamuflaż (intruzja boczna) czy chirurgia? W zależności od różnicy szkieletowej
- Unikanie mechaniki powodującej ekstruzję

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Kontrola zakotwienia pionowego
2. Intruzja boczna za pomocą miniimplantów (jeśli wybrano)
3. Wykończenie

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stabilność pionowa
- Retainer

Częsty błąd: Ekstruzja trzonowców wyciągami klasy II lub III i powiększenie zgryzu otwartego.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

Skierowanie: Wyraźny zgryz otwarty szkieletowy: chirurgia ortognatyczna.

PLAN 24 Zgryz głęboki (hipodywergentny)

Typowe objawy: Krótka dolna część twarzy, zgryz głęboki, silne mięśnie żwacze.

Cele leczenia: Otwarcie zgryzu głębokiego · Stabilny overbite

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Pomiary pionowe i linia uśmiechu
- Kontakt siekaczy dolnych z tkanką podniebienną górną

2 · CELE I DECYZJE

- Ekstruzja boczna może być bardziej odpowiednia w tym typie twarzy
- Intruzja siekaczy w zależności od uśmiechu

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Podniesienie zgryzu
2. Otwieranie zgryzu łukami z odwrotną krzywą
3. Kontrola overbite

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Ochrona zgryzu retainerem podniebiennym górnym
- Obserwacja overbite

Częsty błąd: Naklejenie zamków dolnych bez otwarcia zgryzu i zmaganie się z ich łamaniem.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

PLAN 25 Zgryz głęboki i nadmierne eksponowanie dziąseł

Typowe objawy: Zgryz głęboki, nadmierne eksponowanie dziąseł przy uśmiechu, siekacze górne wydłużone.

Cele leczenia: Intruzja siekaczy górnych · Poprawa estetyki uśmiechu

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Eksponowanie siekaczy w spoczynku i przy uśmiechu
- Długość i ruchomość warg
- Przyczyna dziąsłowa czy zębowa?

2 · CELE I DECYZJE

- Intruzja siekaczy górnych (miniimplanty lub łuk intruzyjny)
- Jeśli przyczyna dziąsłowa, konsultacja periodontologiczna

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Intruzja siekaczy górnych
3. Kontrola torku

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Ostateczna kontrola ze zdjęciem uśmiechu
- Retainer

Częsty błąd: Utrata torku podczas intruzji siekaczy i wychylenie korzeni w stronę podniebienną.

Szczegóły: Moduł 06 · Problemy pionowe i poprzeczne

Skierowanie: Nadmiar dziąseł: periodontologia.

Część F · Problemy zębowe i brak miejsca

PLAN 26 Zatrzymany kieł górny

Typowe objawy: Kieł nie wyrżnął się, kieł mleczny może być na miejscu, pozycja podniebienna lub policzkowa.

Cele leczenia: Wyrżnięcie kła · Ochrona korzeni sąsiednich

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Ocena 3D pozycji (w razie potrzeby CBCT)
- Kontrola resorpcji korzenia siekacza bocznego
- Czy jest miejsce?

2 · CELE I DECYZJE

- Chirurgiczne odsłonięcie + trakcja czy ekstrakcja? W zależności od pozycji i rokowania
- Wspólny plan z chirurgiem

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Najpierw uzyskanie miejsca i solidny łuk zakotwieniowy
2. Chirurgiczne odsłonięcie i zaczep
3. Trakcja lekką siłą
4. Sprowadzenie i tork

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stan dziąseł i pozycja korzenia
- Retainer

Częsty błąd: Rozpoczęcie trakcji bez uzyskania miejsca i łuku zakotwieniowego, co przesuwa sąsiednie zęby.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

Skierowanie: Chirurgia stomatologiczna (odsłonięcie) i w razie potrzeby radiologia dla CBCT.

PLAN 27 Wrodzony brak siekacza bocznego górnego

Typowe objawy: Brak jednego lub dwóch siekaczy bocznych górnych; kły mogą być mezjalnie.

Cele leczenia: Decyzja o otwarciu miejsca (implant/proteza) lub zamknięciu miejsca (kształtowanie kła)

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Kolor, kształt i poziom dziąsła kła
- Relacja zgryzowa
- Wiek pacjenta i opcje odtwórcze

2 · CELE I DECYZJE

- Decyzja wspólnie z lekarzem odtwórczym: otwarcie czy zamknięcie?
- Decyzję przekazać pacjentowi jako plan pisemny

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Mechanika w wybranym kierunku: otwarcie lub zamknięcie miejsca
2. Plan kształtowania kła i przedtrzonowca
3. Równoległość korzeni

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Rozwiązanie tymczasowe w zależności od czasu wykonania uzupełnień
- Retainer

Częsty błąd: Decyzja o ilości miejsca bez konsultacji z lekarzem odtwórczym.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

Skierowanie: Protetyk / implantolog.

PLAN 28 Wrodzony brak drugiego przedtrzonowca dolnego

Typowe objawy: Brak drugiego przedtrzonowca dolnego, ząb mleczny może być na miejscu.

Cele leczenia: Decyzja o zachowaniu zęba mlecznego, zamknięciu miejsca lub rozwiązaniu protetycznym

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Stan korzenia i infraokluzja zęba mlecznego
- Profil i stan stłoczenia

2 · CELE I DECYZJE

- Jeśli występuje stłoczenie, zamknięcie miejsca może być korzystne
- Jeśli ząb mleczny jest w dobrym stanie, można go zachować

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wybrany plan: zamknięcie lub zachowanie
2. Kontrola zakotwienia trzonowca przy zamykaniu

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Zgryz i równoległość korzeni
- Retainer

Częsty błąd: Czekanie latami bez obserwacji infraokluzji zęba mlecznego.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 29 Wczesna utrata zęba mlecznego · Utrzymywacz przestrzeni

Typowe objawy: Wczesna utrata zęba mlecznego, ząb stały jeszcze się nie wyrżnął.

Cele leczenia: Zachowanie miejsca · Normalne wyrzynanie zęba stałego

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Pozycja zawiązka zęba stałego
- Czy utrata miejsca już się rozpoczęła?

2 · CELE I DECYZJE

- Typ utrzymywacza przestrzeni (stały/ruchomy) i czas jego stosowania
- Jeśli utrata miejsca wystąpiła, plan odzyskania miejsca

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zastosowanie utrzymywacza
2. Regularna kontrola
3. Zdjęcie po wyrznięciu zęba stałego

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Obserwacja wyrzynania

Częsty błąd: Pozostawienie utrzymywacza bez kontroli i zablokowanie wyrzynania zęba stałego.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 30 Pionizacja trzonowca (przed protetyką)

Typowe objawy: Dorosły, trzonowiec dolny przechylony w stronę luki, planowana proteza lub implant.

Cele leczenia: Pionizacja trzonowca · Uzyskanie równoległego miejsca pod protezę

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Stan przyzębia i kości
- Wydłużenie zęba przeciwstawnego

2 · CELE I DECYZJE

- Czy mechanika odcinkowa jest wystarczająca?
- Ilość miejsca z lekarzem protetykiem

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zamki odcinkowe i zakotwienie
2. Sprężyna pionizująca lub mechanika wspomagana miniimplantami
3. Kontrola okluzyjna

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Potrzeba retainera po protezie lub implancie

Częsty błąd: Wydłużenie trzonowca podczas pionizacji i stworzenie urazu okluzyjnego.

Szczegóły: Moduł 07 · Mechaniki pomocnicze

Skierowanie: Protetyk / implantolog i periodontologia.

PLAN 31 Ektopowe wyrzynanie pierwszego trzonowca

Typowe objawy: Górny pierwszy trzonowiec zahaczony o korzeń dystalny drugiego zęba mlecznego.

Cele leczenia: Zapewnienie wyrznięcia trzonowca · Zachowanie zęba mlecznego, jeśli to możliwe

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Stopień zahaczenia na pantomogramie
- Resorpcja zęba mlecznego

2 · CELE I DECYZJE

- Krótka obserwacja w celu samoistnej korekty czy interwencja?

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Separator lub prosty aparat do dystalizacji
2. Kontrola po wyrznięciu

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Kontrola utraty miejsca

Częsty błąd: Długa obserwacja i utrata zęba mlecznego oraz miejsca.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

PLAN 32 Ząb nadliczbowy i opóźnione wyrzynanie

Typowe objawy: Ząb stały nie wyrżnął się, w okolicy znajduje się ząb nadliczbowy.

Cele leczenia: Usunięcie przeszkody · Zapewnienie wyrznięcia zęba

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Lokalizacja radiograficzna
- Rozwój korzenia

2 · CELE I DECYZJE

- Ekstrakcja nadliczbowego i obserwacja czy ekstrakcja + odsłonięcie? Decyzja z chirurgiem

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Uzyskanie miejsca i ochrona
2. Chirurgia
3. W razie potrzeby trakcja

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stan korzenia i dziąseł
- Retainer

Częsty błąd: Wykonanie chirurgii bez uzyskania miejsca i czekanie na wyrznięcie zęba.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

Skierowanie: Chirurgia stomatologiczna.

Część G · Pacjenci dorośli, interdyscyplinarni i specjalni

PLAN 33 Pacjent dorosły z problemami przyzębia

Typowe objawy: Utrata kości, migracja i wachlarzowate ustawienie siekaczy, pacjent po leczeniu periodontologicznym lub wymagający takiego leczenia.

Cele leczenia: Wyrównanie zębów lekką siłą · Ochrona zdrowia przyzębia

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Aktualny stan przyzębia i stabilność
- Poziomy kości

2 · CELE I DECYZJE

- Nie rozpoczynać przed zakończeniem leczenia periodontologicznego
- Lekka siła, prosta mechanika

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Zgoda periodontologiczna
2. Niwelacja lekką siłą
3. Częsta kontrola periodontologiczna

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stały retainer
- Program opieki periodontologicznej

Częsty błąd: Stosowanie sił ortodontycznych w aktywnej chorobie przyzębia.

Szczegóły: Moduł 07 · Mechaniki pomocnicze

Skierowanie: Wspólna opieka z periodontologią.

PLAN 34 Uporządkowanie miejsca przed implantacją

Typowe objawy: Niewystarczające miejsce w okolicy brakującego zęba lub przechylone korzenie, planowany implant.

Cele leczenia: Wystarczające miejsce na poziomie korony i korzenia · Równoległe korzenie sąsiednie

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Wymagana ilość miejsca z implantologiem
- Radiografia równoległości korzeni

2 · CELE I DECYZJE

- Mechanika uzyskiwania miejsca i rozwiązanie tymczasowe

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Mechanika odcinkowa lub pełnego łuku
2. Kontrola równoległości korzeni
3. Ochrona miejsca do czasu implantacji

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Proteza tymczasowa i retainer
- Kontrola po implantacji

Częsty błąd: Uzyskanie miejsca tylko na poziomie korony i zbliżenie korzeni.

Szczegóły: Moduł 07 · Mechaniki pomocnicze

Skierowanie: Implantolog.

PLAN 35 Nawrót · Stłoczenie siekaczy dolnych

Typowe objawy: Pacjent po wcześniejszym leczeniu ortodontycznym, brak stosowania retainera, nowe stłoczenie siekaczy dolnych.

Cele leczenia: Ponowna korekta stłoczenia · Tym razem trwała retencja

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Historia wcześniejszego leczenia i retainera
- Zapotrzebowanie na miejsce

2 · CELE I DECYZJE

- Leczenie ograniczone (nakładki lub zamki odcinkowe) zazwyczaj wystarcza
- Może być wymagane IPR

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wyrównanie odcinkowe
2. W razie potrzeby IPR
3. Stały retainer

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stały retainer językowy jest koniecznością
- Program kontroli retainera

Częsty błąd: Ponowna korekta bez zaplanowania retainera.

Szczegóły: Moduł 08 · Wykończenie i stabilność

PLAN 36 Niezgodność Boltona (małe siekacze boczne)

Typowe objawy: Siekacze boczne górne małe lub stożkowate, szpary w odcinku przednim lub niezgodność overjetu.

Cele leczenia: Zgodny zgryz w odcinku przednim · Estetyka

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Analiza Boltona
- Opcje odtwórcze

2 · CELE I DECYZJE

- Rozdzielenie szpar wokół siekaczy bocznych i uzupełnienie czy IPR? Z lekarzem odtwórczym

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wyrównanie
2. Rozdzielenie szpar
3. Wykończenie po uzupełnieniach

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Retainer po uzupełnieniach

Częsty błąd: Zamknięcie odcinka przedniego bez obliczenia niezgodności Boltona i zniszczenie overjetu.

Szczegóły: Moduł 08 · Wykończenie i stabilność

Skierowanie: Stomatolog odtwórczy / estetyczny.

PLAN 37 Przesunięcie linii środkowej

Typowe objawy: Górna i dolna linia środkowa przesunięta względem siebie lub twarzy.

Cele leczenia: Wyrównanie linii środkowych · Znalezienie przyczyny

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Która linia środkowa jest przesunięta? Względem twarzy
- Przesunięcie czynnościowe, asymetryczne stłoczenie lub brak zęba

2 · CELE I DECYZJE

- W zależności od przyczyny: ekstrakcja asymetryczna, wyciągi asymetryczne, rozdzielenie szpar

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Niwelacja
2. Wybrana mechanika asymetryczna
3. Pomiar linii środkowej na każdej wizycie

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Linia środkowa i relacja kłów
- Retainer

Częsty błąd: Wyrównywanie zębów względem siebie bez patrzenia na linię środkową twarzy.

Szczegóły: Moduł 03 · Planowanie kliniczne

PLAN 38 Leczenie ograniczone (odcinek przedni) u dorosłych

Typowe objawy: Dorosły, skarży się tylko na problem estetyczny w odcinku przednim, zgryz boczny dobry.

Cele leczenia: Korekta odcinka przedniego · Niezaburzanie zgryzu bocznego

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Czy problem jest naprawdę ograniczony?
- Zapotrzebowanie na miejsce i zgryz

2 · CELE I DECYZJE

- Przedstawienie pacjentowi ograniczeń leczenia ograniczonego na piśmie
- Nakładki lub ograniczona mechanika stała

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wyrównanie odcinkowe
2. W razie potrzeby IPR
3. Kontrola zgryzu

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stały lub ruchomy retainer

Częsty błąd: Wprowadzanie do leczenia ograniczonego problemu, którego nie da się nim rozwiązać.

Szczegóły: Moduł 03 · Planowanie kliniczne

PLAN 39 Korekta odcinka przedniego w uzębieniu mieszanym (2×4)

Typowe objawy: Uzębienie mieszane, stłoczenie siekaczy, rotacja lub zgryz krzyżowy.

Cele leczenia: Wyrównanie siekaczy · Zmniejszenie ryzyka urazu i problemów czynnościowych

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Zawiązki zębów stałych i stan miejsca
- Relacja trzonowców

2 · CELE I DECYZJE

- Ograniczona, krótka faza; omówienie drugiej fazy z rodziną na początku

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Pierścienie na trzonowce i zamki na siekacze
2. Wyrównanie lekkimi łukami
3. Równoległość korzeni

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Retainer i obserwacja drugiej fazy

Częsty błąd: Wychylenie korzeni blisko zawiązków kłów.

Szczegóły: Moduł 03 · Planowanie kliniczne

PLAN 40 Stłoczenie siekaczy dolnych · Rozwiązanie z IPR

Typowe objawy: Łagodne stłoczenie siekaczy dolnych, zęby w kształcie trójkąta, ryzyko czarnych trójkątów.

Cele leczenia: Wyrównanie bez ekstrakcji · Zmniejszenie czarnych trójkątów

1 · DIAGNOZA I DOKUMENTACJA

- Kształt zębów i grubość szkliwa
- Stan brodawki dziąsłowej
- Zapotrzebowanie na miejsce

2 · CELE I DECYZJE

- Zaplanowanie i zarejestrowanie ilości IPR zgodnie z analizą miejsca

3 · SEKWENCJA MECHANIKI

1. Wyrównanie
2. Zaplanowane IPR
3. Zamknięcie szpar

4 · WYKOŃCZENIE I RETENCJA

- Stały retainer językowy

Częsty błąd: Wykonywanie IPR bez planu i rejestracji.

Szczegóły: Moduł 04 · Zarządzanie miejscem

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Po wybraniu planu wybierz odpowiednią sekwencję łuków z **Tabel Sekwencji Łuków** oraz aparat z **Przewodnika Doboru Aparatów**. Aby pogłębić uzasadnienie planu, wróć do Kompendium do rozdziału **Moduł 03 · Planowanie kliniczne: od listy problemów do mechaniki**.